

Rektal Prolapsus

Çocukta rektal prolapsus çoğunlukla iyi huyludur ve altta yatan bir nedenin belirtisidir; öncelik altta yatanı (kistik fibrozis, kronik kabızlık, parazit, malnütrisyon) araştırmak ve konservatif yönetimdir.

Kabızlık

Kistik fibrozis

Parazit

Konservatif yönetim

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Rektal prolapsus, rektum duvarının (mukoza $\pm$ tüm kat) anal kanaldan dışarı doğru inmesidir. Pik yaş 1-4; sıklıkla defekasyon sırasında ıkınma ile ortaya çıkar, spontan redükte olur. Çoğu vaka altta yatan bir tetikleyicinin (kabızlık, ishalli hastalık, öksürük, malnütrisyon) sonucudur; en kritik dışlanacak tanı kistik fibrozis'tir.

Öykü — yönlendirici sorular

- Prolapsusun süresi, sıklığı, spontan mı yoksa manuel mi redükte olduğu; boyutu ve rengi (mukoza pembe vs iskemik koyu).
- Dışkılama paterni: kabızlık, ıkınma, tuvalette uzun oturma, ağrılı defekasyon; ishal atakları (özellikle kronik/yağlı dışkı).
- Kistik fibrozis ipuçları: tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu, steatore, kilo alamama/gelişme geriliği, tuzlu ter.
- Parazit maruziyeti: kırsal yaşam, karın ağrısı, anal kaşıntı, dizanteri (Trichuris/Entamoeba), tenesmus.
- Beslenme, kilo-boy seyri; kronik öksürük, artmış karın içi basınç (üfleme, obstrüktif üropati).
- Nöromusküler/spinal patoloji, myelomeningosel, geçirilmiş anorektal cerrahi.

Muayene

- Mümkünse ıkındırarak (çömelme/tuvalet pozisyonu) prolapsusu gözlemler; mukozal (kısa, radyal katlantı) vs tam kat (konsantrik halkalar) ayrımı.
- Prolapsus mukozasının canlılığı: ödem, ülserasyon, kanama, iske mi.
- Anal ton, perianal dermatit, fissür; rektal tuşe ile kitle/kabızlık değerlendirmesi.
- Rektal polip veya intussusepsiyon liderini dışla (koyu kırmızı, sap taşıyan kitle → prolapsustan ayır).
- Büyüme parametreleri (persentil), beslenme durumu, digital clubbing.
- Sfinkter tonu düşük + alt ekstremitte nörolojik bulgu → spinal görüntüleme düşün.

Ayırıcı tanı anahtarı: Tam kat prolapsus konsantrik mukozal halkalar gösterir; prolabe rektal polip ise kısa saplı, tek lokalize kitle ile ayrılır; ileokolik intussusepsiyonda anüsten çıkan kitle ile parmak arasına girilebilir (prolapsusta girilemez).

Rektal prolapsus tek başına bir hastalık değil, artmış karın içi basınç + zayıf pelvik destek + yönlendirici bir hastalığın birleşimidir. Altta yatan neden aranmadan yönetim eksik kalır.

Kabızlık / ıkınma (en sık)

- Uzun süreli ıkınma ve tuvalette oturma
- Sert dışkı, ağrılı defekasyon, tutma davranışı
- Fonksiyonel kabızlık (Rome IV) çoğu vakanın zemininde

Kistik fibrozis (mutlaka dışla)

- Prolapsus, KF'li çocukların %3-20'sinde; bazen ilk bulgu
- Steatore, hacimli dışkı, malnütrisyon, kronik öksürük
- Ter testi ZORUNLU — tüm idiyopatik vakalarda

İshalli hastalık

- Akut gastroenterit, tenesmus, sık defekasyon
- Kronik ishal, malabsorbsiyon

Parazit enfeksiyonu

- Trichuris trichiura (ağır enfeksiyon → prolapsus klasik)
- Entamoeba histolytica, Giardia; endemik bölgeler
- Dışkı mikroskopisi / antijen testi

Malnütrisyon / anatomik zemin

- İskiorektal yağ kaybı, zayıf pelvik destek
- Sakrumun düz seyri (küçük çocuk anatomisi)
- Ehlers-Danlos, bağ dokusu gevşekliği

Nöromusküler / diğer

- Myelomeningosel, spinal disrafizm, sakral agenezi
- Kronik öksürük (pertussis), artmış intraabdominal basınç
- Rektal polip veya intussusepsiyon (lider nokta)

03 Karar akışı

İlk redüksiyon ve stabilizasyondan sonra öncelik altta yatan nedeni ortaya koymaktır. Aşağıdaki ağaç, tanısal yol ile konservatif yönetimi birleştirir.

BAŞLANGIÇ

Anüsten protrüde doku ile başvuru

Prolabe segmentin canlılığını ve redükte edilebilirliğini değerlendir; tam kat mı mukozal mı ayır.

KARAR 1

İnkarserasyon / iskemi / redükte edilemeyen prolapsus var mı?

Koyu/mor renk, ödem, kanama, şiddetli ağrı veya manuel redüksiyona yanıtızlık.

EVET → Acil

HAYIR → Elektif değerlendirme

ACİL MÜDAHALE

Cerrahi konsültasyon + acil redüksiyon

Analjezi/sedasyon altında nazik manuel redüksiyon; ödem için topikal şeker/soğuk kompres. Redükte olmuyor veya iskemi ilerliyorsa cerrahi eksplorasyon.

ADIM 1

Nazik redüksiyon + altta yatanı araştır

Manuel redüksiyon; ardından tanısal basamaklı tetkik (Bölüm 04) başlat.

ADIM 2

Zorunlu ilk basamak: KF ter testi + dışkı tetkiki

Tüm idiyopatik prolapsusta ter testi; dışkı mikroskopisi (parazit) ve gerekirse dışkı elastazı.

KARAR 2

Spesifik altta yatan neden saptandı mı?

KF, parazit, kronik ishal veya diğer sekonder neden.

EVET → Nedene yönelik

HAYIR → İdiyopatik/fonksiyonel

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ

Altta yatanı tedavi et

KF → multidisipliner KF yönetimi + pankreatik enzim replasmanı; parazit →

KONSERVATİF YÖNETİM

Kabızlık tedavisi + tuvalet eğitimi

Osmotik laksatif (PEG), lifli beslenme, tuvalette ıkınma/uzun oturmayı azalt, ayak

antihelmintik; ishal → etiyolojiye yönelik.
Prolapsus çoğunlukla neden tedavi edilince
geriler.

desteđi. Çođu vaka 3-12 ayda spontan
düzeldir.

KARAR 3

6-12 ay optimal konservatif yönetime rağmen inatçı/tekrarlayan mı?

Uyum doğrulanmış, kabızlık kontrol altında olmasına rağmen prolapsus devam ediyor.

EVET → Girişimsel

HAYIR → İzlem

İLERİ TEDAVİ

Skleroterapi veya cerrahi

Submukozal skleroterapi (%15 hipertonic
salin/%5 fenol vb.) ilk girişim; başarısızlıkta
cerrahi (Thiersch, sütür rektopeksi, transanal
rezeksiyon).

SÜRDÜR

Konservatifi devam ettir

Laksatif idamesi, tuvalet davranışı, büyüme
takibi; sıklık azalırken kademeli geri çekilme.

Tetkik, sıklık sırasına ve önceki basamağın sonucuna göre kademelidir. Ter testi ve dışkı tetkiki idiyopatik her vakada zorunlu ilk basamaktır.

Rektal prolapsusta basamaklı tanısal değerlendirme

BASAMAK	TETKİK / EŞİK
1 — Ter testi (zorunlu)	Pilokarpin iyontoforezi; $Cl^- \geq 60$ mmol/L pozitif, 30-59 ara
1 — Dışkı mikroskopisi	3 örnek; parazit yumurta/kist, Trichuris/Entamoeba
2 — Dışkı elastaz-1	<200 µg/g yetersizlik; <100 µg/g ağır ekzokrin pankreas ye
2 — Tam kan + demir	Hb, ferritin, eozinofili
3 — Abdomen düz grafi / geçiş	Fekal yük değerlendirmesi (klinik yeterliyse gerekmez)
3 — Çölyak serolojisi	Doku transglutaminaz IgA + total IgA

BASAMAK	TETKİK / EŞİK
4 — Kolonoskopi / rektosigmoidoskopi	Kanama, kitle veya polip şüphesi
4 — Spinal MR	Anormal sfinkter tonu / nörolojik bulgu

05

Kırmızı bayraklar

Aşağıdaki bulgular acil müdahale, ileri görüntüleme veya cerrahi konsültasyonu tetikler.

- İnkarsere / redükte edilemeyen prolapsus veya iskemi bulguları (koyu-mor mukoza, kanama, şiddetli ağrı).

- Ter testi pozitif veya steatore + gelişme geriliği (kistik fibrozis).

- Anüsten çıkan doku ile parmak arasına girilebilmesi (intussusepsiyon lideri) veya lokalize saplı kitle (polip).

- Rektal kanama, kilo kaybı, kronik ishal → IBD / soliter rektal ülser / neoplazi.

- Düşük sfinkter tonu + alt ekstremitte nörolojik defisit → spinal patoloji.

- 4 yaş üzeri ilk kez başlayan veya optimal konservatif tedaviye dirençli prolapsus.

Tedavinin temeli akut redüksiyon, altta yatanın (özellikle kabızlık ve parazit) dozlu tedavisi ve tuvalet davranışının düzenlenmesidir. Cerrahi/skleroterapi yalnızca dirençli olgularda.

Konservatif yönetim çocukların büyük çoğunluğunda etkilidir; kabızlık kontrol altına alınıp ıkınma azaltıldığında prolapsus genellikle aylar içinde geriler. Manuel redüksiyon için ödemli mukozaya topikal granül şeker (osmotik ödem çözücü) uygulanabilir.

Rektal prolapsusta dozlu medikal tedavi

İLAÇ / BASAMAK	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
PEG 3350/4000 (idame — kabızlık)	0.4-0.8 g/kg/gün PO (maks başlangıç ~17 g/gün); dışkı yumu
PEG 3350 (fokal disempaksiyon)	1-1.5 g/kg/gün PO, 3-6 gün (maks 100 g/gün)
Laktuloz (alternatif osmotik)	1-2 g/kg/gün (1.5-3 mL/kg/gün), 1-2 doza böl (maks 60 mL/g
Mebendazol (Trichuris/askaris)	100 mg PO 2×/gün, 3 gün (veya 500 mg tek doz)
Albendazol (alternatif antihelmintik)	400 mg PO tek doz (Trichuris'te 3 gün); <2 yaş 200 mg

İLAÇ / BASAMAK	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Metronidazol (Entamoeba histolytica)	35-50 mg/kg/gün PO, 3 doza böl, 7-10 gün (maks 2250 mg/g)
Pankreatik enzim (KF saptanırsa)	Lipaz 500-2500 IU/kg/öğün (maks 10.000 IU/kg/gün veya 2500 IU/kg/gün)
Skleroterapi (dirençli olgu)	Submukozal %15 hipertonic salin veya %5 fenol (badem yağı)

Manuel redüksiyon + topikal şeker

Tuvalette ayak desteği/tabure

İkınma süresini kısalt

Lif + sıvı

Cerrahi: yalnızca refrakter

İzlem, kabızlık kontrolünün sürdürülmesi, altta yatan nedenin tedavi yanıtı ve prolapsus sıklığının azalması üzerine kuruludur.

İzlem hedefleri

- Günlük yumuşak, ağrısız dışkılama; ıkınmasız defekasyon.
- İlk 4-6 haftada telefon/poliklinik ile laksatif doz titrasyonu.
- Prolapsus sıklığı azaldıkça laksatifi kademeli azalt; erken kesme nüks riski.
- Büyüme (persentil) ve beslenme takibi; KF/malnütrisyonunda ayrı izlem.
- Parazit tedavisi sonrası kontrol dışı incelemesi.

Aile eğitimi ve davranış

- Tuvalette uzun oturmayı ve zorlu ıkınmayı önle; ayak desteği ile pelvik açı düzeltilir.
- Prolapsus olursa ebeveyne nazik manuel redüksiyon öğret; iskemi bulgusunda acile başvuru.
- Düzenli tuvalet rutini (öğün sonrası gastrokolik refleks).
- Lif ve sıvı alımını artır; tutma davranışını azalt.
- Çoğu çocukta prognoz mükemmel; 4 yaşından sonra spontan düzelme sıktır.

Cerrahiye yönlendirme eşiği: uygun uygulanan konservatif tedaviye 6-12 ay yanıtsızlık, tam kat kalıcı prolapsus veya inkarserasyon. Skleroterapi genellikle ilk girişimsel basamaktır; başarısızlıkta Thiersch, sütür/laparoskopik rektopeksi veya transanal yaklaşım değerlendirilir.

Kaynaklar

1. Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, ve ark. Functional Disorders: Children and Adolescents (Rome IV). Gastroenterology. 2016;150:1456-1468.
2. Tabbers MM, DiLorenzo C, Berger MY, ve ark. Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children: ESPGHAN/NASPGHAN Evidence-Based Recommendations. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014;58:258-274.
3. Farrell PM, White TB, Ren CL, ve ark. Diagnosis of Cystic Fibrosis: Consensus Guidelines from the Cystic Fibrosis Foundation. J Pediatr. 2017;181S:S4-S15.
4. Cares K, El-Baba M. Rectal Prolapse in Children: Significance and Management. Curr Gastroenterol Rep. 2016;18:22.

Uyarı: Bu belge pediatrik gastroenteroloji uzmanları için hazırlanmış bir klinik karar-destek aracıdır; bireysel hasta yönetiminin yerini tutmaz. Dozlar hastanın yaşı, kilosu, böbrek/karaciğer fonksiyonu ve güncel ürün bilgisine göre doğrulanmalıdır.